

Blueprint *instrukcja obsługi siebie*

Pisemne podsumowanie 20 sesji terapii. 5–10-stronnicowy dokument, który klient zabiera ze sobą po terapii i regularnie przegląda. Fairburn 2008: ważniejszy niż pojedyncze techniki.

CZAS: 60 min · w sesji 18–20 Ostatnia faza CBT-E · obowiązkowy element

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008); Marlatt & Gordon (1985)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **siedem sekcji blueprintu** (sekcja 1), **jak go tworzyć** (sekcja 2). Sekcja 3 — szkic sekcji 1–4. Sekcja 4 — szkic sekcji 5–7.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Blueprint (w CBT-E „*personal plan*” lub „*blueprint for the future*”) — pisemne **podsumowanie** 20 sesji terapii, stworzone przez klienta z terapeutą na sesjach 18–20. **5–10-stronnicowy dokument**, który klient *zabiera* po terapii. Zawiera siedem sekcji: moja historia, co podtrzymywało zaburzenie, czego się nauczyłam, sygnały wczesne nawrotu, plan reagowania na ślizgi, wartości i cele życiowe, lista wsparcia. Fairburn (2008): blueprint jest **ważniejszy niż pojedyncze techniki** — jest *przewodnikiem* klienta na 2–5 lat. Klient wraca do blueprintu w kryzysach jak do *instrukcji obsługi siebie*. To **najważniejszy** deliverable terapii.

01 = Siedem sekcji blueprintu

1 · MOJA HISTORIA

Kiedy zaczęło się, jak się rozwijało, momenty kluczowe. Bez ocen — kontekst.

2 · CO PODTRZYMYWAŁO ZABURZENIE

Moje konkretne czynniki: *overvaluation*, reguły, body-checking, emocje, sekret. Indywidualny model Fairburna.

3 · CO SIĘ NAUCZYŁEM/-AM

Konkretne wnioski. „Reguły żywieniowe nasilają epizody”, „moje emocje są tolerowalne”. Lekcje z 20 sesji.

4 · MOJE NARZĘDZIA

Regularne jedzenie 3+2, surfowanie po impulsie (*urge surfing*), TIPP, plan awaryjny, dziennik. Które działają najlepiej dla mnie.

5 · MOJE SYGNAŁY WCZESNE

10–15 indywidualnych sygnałów z poprzedniego handoutu. Plus plan reakcji na każdy.

6 · WARTOŚCI I CELE ŻYCIOWE

Co chcę w życiu *poza* „nie mieć bulimii”. Pasje, relacje, praca, twórczość. Pozytywne cele życiowe.

7 · LISTA WSPARCIA + PLAN BOOSTER SESSIONS

Osoby zaufane (imiona, telefony), terapeuta (kontakt), grupa wsparcia, książki, strony internetowe. Plus harmonogram *sesji przypominających* w kolejnych miesiącach (1 mies., 3 mies., 6 mies., 12 mies.).

02 ● Jak tworzyć blueprint

Blueprint *nie* jest pracą domową — jest tworzony **w sesjach 18–20** wspólnie z terapeutą. To *współpraca*: klient pisze, terapeuta zadaje pytania, pomaga uporządkować. Format: **5–10 stron**, czytelny układ, lista wsparcia z *numerami telefonów*. Cel: dokument, do którego klient wraca *za 6 miesięcy, za rok, za 5 lat*. Pisz jak do *siebie z przyszłości*.

03 \ Szkic blueprintu — sekcje 1–4

1 · MOJA HISTORIA (3–5 ZDAŃ)

— *kiedy, jak, momenty kluczowe*

3 · CO SIĘ NAUCZYŁEM/-AM (3–5 WNIOSKÓW)

— *kluczowe lekcje z terapii*

2 · CO PODTRZYMYWAŁO (3–5 CZYNNIKÓW)

— *moje konkretne czynniki podtrzymujące*

4 · MOJE NAJSILNIEJSZE NARZĘDZIA (3–5)

— *techniki, do których wracam*

04 \ Szkic blueprintu — sekcje 5–7

5 · TOP 3 SYGNAŁY WCZESNE

— *z poprzedniego handoutu, najczęstsze u mnie*

6 · MOJE 3 WARTOŚCI / CELE ŻYCIOWE

— *co chcę w życiu poza „nie mieć bulimii”*

7 · LISTA WSPARCIA (3 OSOBY + 3 ZASOBY)

— *imiona, telefony, grupy, książki, strony*

Klucz: blueprint jest *najważniejszym* deliverable terapii. Fairburn (2008): „*blueprint jest ważniejszy niż pojedyncze techniki*”. Powód: techniki są *narzędziami*, blueprint jest *mapą*. Bez mapy narzędzia są bezużyteczne. Z mapą klient wie, *kiedy* użyć którego narzędzia. Mechanizm: pisemne podsumowanie tworzy **trwałą referencję**. Klient za 6 miesięcy może *nie pamiętać* szczegółów technik, ale pamięta, że *blueprint istnieje* i wraca do niego. Blueprint staje się *strażnikiem zdobytej wiedzy*. **Forma:** papierowa i cyfrowa. Papierowa — w widocznym miejscu w domu, łatwa do sięgnięcia. Cyfrowa — w telefonie, dostępna wszędzie. Niektórzy klienci tworzą *plakat* z kluczowymi punktami — wisi na ścianie. **Aktualizacja:** blueprint *nie* jest statyczny. Co 6–12 miesięcy warto go przeglądać i aktualizować — nowe doświadczenia, nowe sygnały, nowe wartości. Na *sesjach przypominających* (booster) — pierwsza rzecz, którą terapeuta omawia z klientem. **Bez blueprintu** — typowo 60–70% wiedzy zdobytej w terapii *rozprasa się* w ciągu 12 miesięcy. Z blueprintem — pozostaje *strukturalna* baza, którą klient może aktywować w *chwili potrzeby*. To *najsilniejszy* czynnik trwałości efektów CBT-E. Marlatt & Gordon (1985) opisali tę technikę pierwsi — Fairburn (2008) zaadaptował dla zaburzeń odżywiania.